ICS 11.0.20
C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.8—2008

针灸技术操作规范　第8部分:皮内针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 8:Intradermal needle

2008-04-23 发布　　2008-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为21个部分：

——第1部分：艾灸；
——第2部分：头针；
——第3部分：耳针；
——第4部分：三棱针；
——第5部分：拔罐；
——第6部分：穴位注射；
——第7部分：皮肤针；
——第8部分：皮内针；
——第9部分：穴位贴敷；
——第10部分：穴位埋线；
——第11部分：电针；
——第12部分：火针；
——第13部分：芒针；
——第14部分：鍉体；
——第15部分：眼针；
——第16部分：鼻针；
——第17部分：口唇针；
——第18部分：腹针；
——第19部分：腕踝针；
——第20部分：毫针基本刺法；
——第21部分：毫针针刺手法。

本部分为GB/T 21709的第8部分。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分负责起草单位：成都中医药大学。

本部分参加起草单位：北京中医药大学。

本部分主要起草人：余曙光、唐勇、刘清国、罗玲、袁成凯、曾芳。

针灸技术操作规范　第8部分:皮内针

1　范围

GB/T 21709的本部分规定了皮内针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项和禁忌。

本部分适用于皮内针技术操作。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于GB/T 21709的本部分。

2.1

皮内针　intradermal needle

用于皮内埋藏的针具。

2.2

颗粒型皮内针　grain-like intradermal needle

针尾呈椭圆颗粒状的皮内针,又称麦粒型皮内针。

2.3

揿钉型皮内针　thumbtak intradermal needle

针尾呈环形并垂直于针身的皮内针,又称图钉型皮内针。

3　操作步骤与要求

3.1　施术前准备

3.1.1　针具选择

根据疾病和操作部位的不同选择相应的皮内针。

3.1.2　部位选择

宜选择易于固定且不妨碍活动的腧穴。

3.1.3　体位选择

宜选择患者舒适、医者便于操作的治疗体位。

3.1.4　环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

3.1.5　消毒

3.1.5.1　针具消毒

应选择高压蒸汽消毒法。宜使用一次性皮内针。

3.1.5.2　部位消毒

宜用75%乙醇或1%～2%碘伏在施术部位消毒。

3.1.5.3　医者消毒

医者双手应先用肥皂水清洗,再用75%乙醇棉球擦拭。

3.2　施术方法

3.2.1　进针

3.2.1.1　颗粒型皮内针

一手将腧穴部皮肤向两侧舒张,另一手持镊子夹持针尾平刺入腧穴皮内。

3.2.1.2 揿钉型皮内针

一手固定腧穴部皮肤，另一手持镊子夹持针尾直刺入腧穴皮内。

3.2.2 固定

3.2.2.1 颗粒型皮内针

宜先在针尾下垫一橡皮膏，然后用脱敏胶布从针尾沿针身向刺入的方向覆盖、粘贴固定。

3.2.2.2 揿钉型皮内针

宜用脱敏胶布覆盖针尾、粘贴固定。

3.2.3 固定后刺激

宜每日按压胶布 3 次～4 次，每次约 1 min，以患者耐受为度，两次间隔约 4 h。埋针时间参见附录 A。

3.2.4 出针

一手固定埋针部位两侧皮肤，另一手取下胶布，然后持镊子夹持针尾，将针取出。

3.3 施术后处理

应用消毒干棉签按压针孔，局部常规消毒。

4 注意事项

4.1 初次接受治疗的患者，应首先消除其紧张情绪。

4.2 老人、儿童、孕妇、体弱者宜选取卧位。

4.3 埋针部位持续疼痛时，应调整针的深度、方向，调整后仍疼痛应出针。

4.4 埋针期间局部发生感染应立即出针，并进行相应处理。

4.5 关节和颜面部慎用。

5 禁忌

5.1 红肿、皮损局部及皮肤病患部。

5.2 紫癜和瘢痕部。

5.3 体表大血管部。

5.4 孕妇下腹、腰骶部。

5.5 金属过敏者。

附 录 A
（资料性附录）
埋 针 时 间

A.1 宜 2 d～3 d，可根据气候、温度、湿度不同，适当调整。

A.2 同一埋针部位出针 3 d 后可再次埋针。